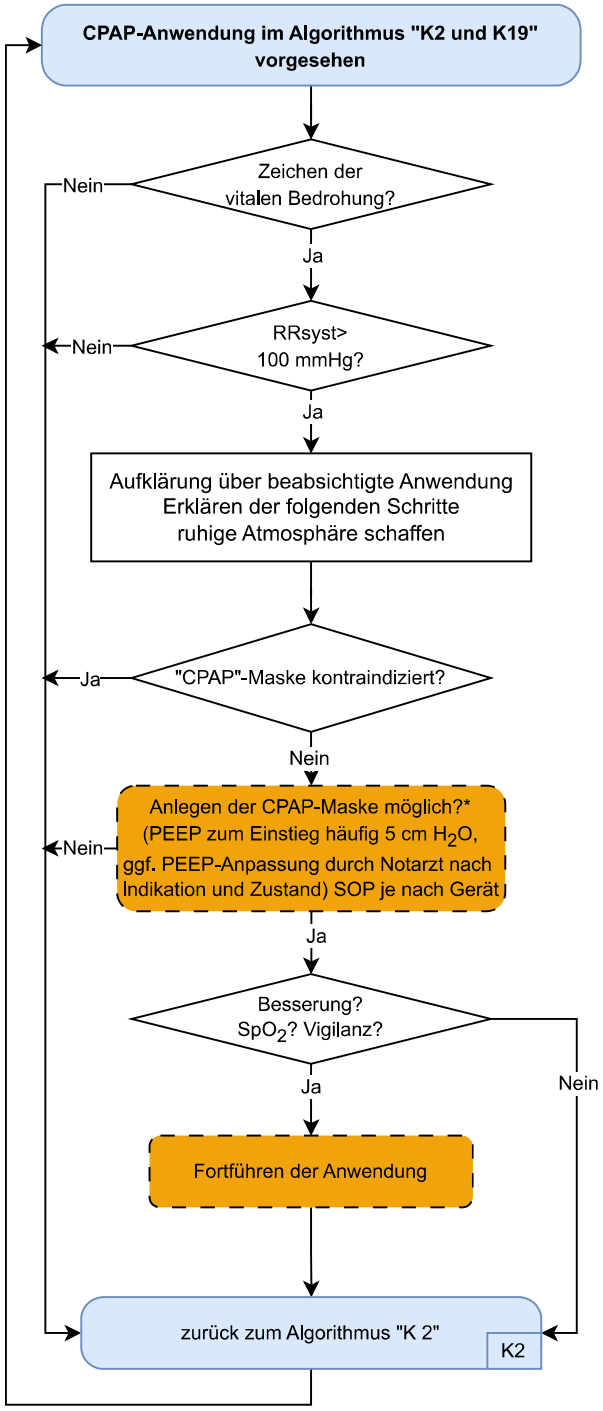
P 2 CPAP-Anwendung



Zeichen der vitalen Bedrohung:
starke Dyspnoe, Kaltschweißigkeit, Angst, Unruhe,
Auskultation der Lunge, bds. feuchte Rasselgeräusche, SpO_2 < 90 %

Vorteile:
Vermeidung von Problemen der orotrachealen Intubation
Klassische Analgosedierung nicht erforderlich (unerwünschte Wirkungen)
nosokomialen Beatmungspneumonien deutlich seltener

Nachteile:
kein direkter Zugang zu den Atemwegen (erschwerte Absaugung)
kein Aspirationsschutz
erforderliche Patienten-Compliance

Voraussetzungen:
Spontanatmung und Bewusstsein erhalten, Patient kooperativ,
Hämodynamik ohne Katecholamine stabil, keine malignen Arrhythmien,
Keine Hypersekretion oder obere GI-Blutung, kein Erbrechen, kein Ileus

Kontraindikationen:
fehlende Schutzreflexe, Erbrechen, obere GI-Blutung/Ileus,
fehlende Eigenatmung, Verlegung der Atemwege,
Verletzungen im Gesichtsbereich

***nicht möglich bei:** unzureichender Kooperation,
Maskenproblemen (Bart, Erbrochenes etc.)
Was beruhigt den Patienten?
1. Rascher Anstieg der O_2-Sättigung
2. Kompetentes Handeln des Personals

Abbruchkriterien:
Vigilanzverschlechterung
Atemstillstand, Schnappatmung
keine ausreichende klinische Besserung auf CPAP innerhalb von 10 Min.
Sauerstoffsättigung persistierend unter 85 % (relativ, z.B. Fibrose, COPD)
Erbrechen